

4A. Lumbar: anamnesis dirigida

La postura aporta pistas, pero el diagnóstico depende de distribución, alivio, neurología y patrón de carga.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Empeora sentado, al inclinarse hacia delante o al levantar peso?	Patrón discogénico posible.	Reduce ese patrón; no excluye disco sintomático.	Movimientos repetidos y observar centralización/periferización.
¿Empeora al extender o girar el tronco, o al estar de pie quieto?	Patrón facetario posible.	Reduce patrón facetario, pero no descarta faceta.	Extensión-rotación; MBB si se plantea RF, no por exploración aislada.
¿El dolor baja por la pierna con hormigueo, descarga o empeora al toser/estornudar?	Dolor radicular/radiculopatía.	Reduce radicular; no excluye dolor referido.	SLR/slump o femoral stretch, miotomas, sensibilidad y reflejos.
¿Le aparecen dolor, pesadez o debilidad en piernas al caminar o estar de pie y tiene que pararse?	Estenosis con claudicación neurógena.	Reduce estenosis sintomática; no la imagen anatómica.	Distancia de marcha, alivio sentado/flexionado, neurología y pulsos.
¿Mejora al sentarse, inclinarse hacia delante o apoyarse en el carro?	Refuerza claudicación neurógena.	Si solo mejora al detenerse, considerar claudicación vascular.	Pulsos, piel, marcha y comparación con bicicleta/flexión si procede.
¿Señala el dolor bajo la EIPS y empeora al girarse en cama o apoyar una pierna?	Complejo sacroilíaco posible.	Reduce SI; revisar cadera, lumbar y glúteo.	Fortin y clúster de provocación SI.
¿Tiene pérdida de fuerza progresiva, anestesia en silla de montar o cambios recientes de esfínteres?	Cauda equina o déficit neurológico grave.	Reduce alarma inmediata, no otras banderas rojas.	Neurología completa, RM y valoración urgente.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Flexión y extensión son pistas, no diagnósticos. Estenosis clínica exige síntomas con marcha/bipedestación y alivio postural; radiculopatía exige concordancia neuroanatómica y neurológica.

4B. Lumbar: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Movimientos repetidos	Repetir flexión o extensión lumbar y mapear si el dolor se centraliza o se desplaza distalmente.	Centralización apoya preferencia direccional; perifерización obliga a reducir/cambiar movimiento y revisar raíz.	Sin cambio no excluye disco ni identifica faceta; solo falta una respuesta direccional clara.
Extensión-rotación	De pie, extender e inclinar/rotar hacia el lado doloroso con control.	Dolor axial local puede apoyar patrón facetario, pero también carga otras estructuras.	No descarta faceta; ni positivo ni negativo sustituyen un MBB cuando se plantea RF.
SLR / Lasègue	Supino, elevar pierna con rodilla extendida; usar dorsiflexión cervical/tobillo para diferenciación estructural.	Reproduce dolor radicular habitual bajo la rodilla, típicamente 30°-70°: apoya L5/S1.	Reduce radiculopatía discal L5/S1, pero no excluye ni valora bien L2-L4.
SLR cruzado	Elevar la pierna asintomática con rodilla extendida.	Provoca dolor radicular en la pierna sintomática: bastante específico para hernia discal relevante.	Es frecuente que sea negativo; no excluye radiculopatía.
Slump	Sentado: flexión torácico-cervical, extensión de rodilla y dorsiflexión; liberar cuello para diferenciar.	Reproduce síntomas habituales y cambian al liberar tensión: apoya mecanosensibilidad neural.	Reduce mecanosensibilidad, pero no excluye compresión radicular.
Femoral stretch	Prono o lateral: flexionar rodilla y extender suavemente cadera evitando hiperlordosis.	Dolor anterior de muslo habitual: apoya raíces L2-L4/femoral.	Reduce radiculopatía alta; no excluye dolor de cadera o psoas.
Motor-reflejos-marcha	Talones L4-L5, puntillas S1; fuerza segmentaria, sensibilidad, rotuliano y aquileo comparativos.	Déficit miotómico o reflejo asimétrico concordante: radiculopatía verdadera y cambia prioridad.	Neurología normal no excluye dolor radicular sin pérdida axonal.
Marcha/flexión + pulsos	Medir distancia de marcha y alivio sentado/inclinado; explorar pulsos y repetir con bicicleta si procede.	Piernas al estar de pie/caminar y alivio con flexión: claudicación neurógena; pulsos pobres sugieren vascular.	No excluye estenosis radiológica; cuestiona que sea el generador sintomático.

SÍNTESIS CLÍNICA

Radiculopatía se apoya en concordancia de distribución, neurodinamia y déficit/reflejo, no en dolor de pierna aislado. El dolor facetario no se confirma con extensión-rotación: si la RF es una opción, la prueba relevante es el bloqueo de ramos mediales.

4C. Lumbar: imagen, bloqueos y escalada

No existe una ecografía lumbar “normal” capaz de descartar hernia, estenosis o dolor discogénico; úsala para sonoanatomía y guía, no para diagnosticar el disco.

Problema	Intervención seleccionada	Regla de seguimiento
Dolor facetario crónico probable	Tras manejo conservador, MBB con pequeño volumen y registro funcional. Si respuesta claramente concordante según protocolo → valorar RF de ramos mediales.	No hacer RF solo por dolor a la extensión o artrosis en RM.
Radiculopatía aguda/subaguda grave concordante	Epidural puede reducir dolor/discapacidad principalmente a corto plazo. La vía (caudal/interlaminar/transforaminal) depende del nivel, objetivo, imagen y seguridad.	No prometer 6 meses ni repetir por calendario; repetir solo si beneficio clínico relevante y plan funcional.
Estenosis con claudicación	Ejercicio flexión-tolerante, marcha asistida/bici, medicación; epidural tiene beneficio limitado y no suele mejorar dolor a corto plazo de forma importante.	Derivar si deterioro neurológico, función inaceptable o correlación quirúrgica.
Fracaso tras epidural	Revisar diagnóstico, nivel, adherencia, déficit e imagen. PRF de DRG es opción especializada de evidencia limitada, no paso automático a los 4 meses.	Cirugía por déficit/progresión o dolor incapacitante con compresión concordante, no solo por duración.

GUÍA DE IMAGEN

Ecografía: identificar sacro, láminas, facetas, transversas, multífido, hiato y vasos; documentar diana y aguja. En epidural caudal, la ecografía confirma entrada por hiato pero no demuestra distribución cefálica. En técnicas epidurales/foraminales y RF, seguir estándares de imagen, contraste y seguridad del centro.

FARMACOLOGÍA

AINE oral corto si es seguro. NICE desaconseja gabapentinoides, benzodiacepinas y corticoide oral para ciática; evitar opioides crónicos. El ciclo fijo de prednisona no debe figurar como pauta universal.

MENSAJE AL PACIENTE

La inyección epidural no recoloca el disco ni evita necesariamente una cirugía. Su objetivo es disminuir el dolor radicular durante semanas o meses en algunos pacientes para recuperar sueño, marcha y ejercicio mientras vigilamos la fuerza y la evolución.

4D. Lumbar: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional. Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Axial mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días; actividad y ejercicio desde el inicio.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días; no cronificar si no mejora función.
Neuropático seleccionado	Duloxetina 30 mg/día 1-2 semanas y después 60 mg/día; alternativa: amitriptilina 10 mg/noche, subir 10 mg cada 7 días hasta 25-50 mg.	Ensayo 6-8 semanas; elegir uno, no combinarlos de entrada.
Ciática	No usar de rutina prednisona, benzodiacepinas ni gabapentinoides; opioide solo rescate excepcional con fecha de fin.	Revisar fuerza y evolución en 1-2 semanas si cuadro agudo relevante.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
MBB lumbar	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,3-0,5 mL por ramo; registrar tarea y duración.
Epidural transforaminal	Dexametasona no particulada 10 mg + salino o anestésico local de baja concentración según protocolo.	Total 1,5-3 mL por raíz; contraste y control radiológico según estándar.
Epidural interlaminar	Dexametasona 10 mg + suero salino 0,9% con o sin anestésico local.	Total 4-6 mL; adaptar a nivel, estenosis y protocolo.
Epidural caudal	Dexametasona 10 mg + salino 0,9% con o sin ropivacaína 0,1-0,2%.	Total 10-20 mL; ecografía confirma hiato, no extensión cefálica.

REHABILITACIÓN

Actividad graduada, fuerza de tronco/cadera y exposición a flexión o extensión según patrón durante 6-12 semanas; 4-8 sesiones si precisa guía.

EVITAR

RF sin bloqueo pronóstico concordante, corticoide particulado transforaminal como opción rutinaria, repetir epidural por calendario o superar dosis acumulada de anestésico local.